



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG

Terakreditasi B (Baik Sekali) **BAN - PT**

Program Studi :

1. Diploma III Kebidanan
2. Sarjana Keperawatan
3. Profesi Ners
4. Sarjana Gizi
5. Sarjana Kebidanan
6. Pendidikan Profesi Bidan

Alamat : Jl. Veteran Mancar Peterongan Jombang Telp./Fax. 0321 - 877025

Jombang, 27 November 2025

Nomor : 371/SHJ/S.Pend/XI/2025

Kepada,-

Lampiran : -

Yth. Direktur RS Prima Husada Sukorejo

Perihal : Pengantar Studi Pendahuluan
Penelitian

Di -

TEMPAT

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir berupa Skripsi bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Husada Jombang Tahun Akademik 2025/ 2026, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : **SILFI FAUZIYAH**

NIM : 2024 03 0269

Prodi : Sarjana Keperawatan STIKes Husada Jombang

Tempat Penelitian : Di RS Prima Husada Sukorejo

Bersama ini kami mohon agar mahasiswa termaksud mendapatkan ijin dan kesempatan melakukan studi pendahuluan serta diberikan data – data yang berkaitan dengan Penelitian dengan judul “ **PENGARUH TEKNIK RELAKSASI GENGAM JARI TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PREE OPERASI DI RUANG MATERNITAS RS PRIMA HUSADA SUKOREJO** ”.

Demikian atas bantuan dan kebijakaannya di sampaikan ucapan terima kasih.

Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Husada Jombang


Bagus Sulianto, ST.,MM.

NPP. 010706031

PROPOSAL

PENGARUH TEKNIK RELAKSASI GENGAM JARI TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI CAESAR DI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

PENELITIAN *PRA EKSPERIMEN*



Oleh :

SILFI FAUZIYAH
NIM : 2024030269

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
2025**

PROPOSAL

PENGARUH TEKNIK RELAKSASI GENGAM JARI TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI CAESAR DI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)
Pada Program Studi Ilmu Keperawatan
STIKes Husada Jombang



Oleh :

SILFI FAUZIYAH
NIM : 2024030269

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Skripsi Oleh:

Nama : Silfi Fauziyah

NIM : 2024030269

Judul : Pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar di RS Prima Husada Sukorejo

Telah disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji Proposal Skripsi

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing 2

(Enny Puspita, S.ST.,Ns.,M.Kes)

(Dwi Uswatun Sholikhah, S.Kep.,Ns.,M.Kep)

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal ini telah dipresentasikan dan dipertahankan

Di depan tim penguji

Tanggal :

MENGESAHKAN,

TIM PENGUJI

Tandatangan

Ketua : Prawito, S.Kep.,Ns., M.Kep (.....)
NPP : 011305109

Anggota : Enny Puspita, S.ST.,Ns.,M.Kes. (.....)
NPP : 011305105

Anggota : Dwi Uswatun Sholikhah, S.Kep.,Ns.,M.Kep. (.....)
NPP : 011305120

Mengetahui,

Ketua STIKES HUSADA
JOMBANG

Ketua Prodi S1 Keperawatan

Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., M.M
NPP. 010201001

Sylvie Puspita, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NPP. 011305103

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar di RS Prima Husada Sukorejo”. Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada Prodi Sarjana Keperawatan STIKes Husada Jombang.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur RS Prima Husada Sukorejo, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana dan melakukan penelitian di RS Prima Husada
2. Dra. Hj. Soelijah Hadi, M. Kes, MM, Selaku Ketua STIKes Husada Jombang.
3. Sylvie Puspita, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku ketua Prodi Sarjana Keperawatan STIKes Husada Jombang.
4. Prawito, S.Kep.,Ns.,M.Kep. selaku penguji proposal
5. Enny Puspita, S.ST.,Ns.,M.Kes, Selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, masukan, arahan selama penyusunan proposal ini.
6. Dwi Uswatun Sholikhah, S.Kep.,Ns.,M.Kep, Selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan, masukan, arahan selama penyusunan proposal ini.
7. Kedua Orang Tua yang telah memberi dukungan moril dan material selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang.
9. Teman-teman seangkatan yang telah memberi dukungan dalam penyusunan proposal ini.
10. Semua pihak yang telah membantu peneliti sehingga proposal ini dapat terselesaikan.

Saya menyadari proposal ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya karya ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin.

Jombang, November 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SIMBOL	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Dasar Teknik Relaksasi Genggam Jari	6
2.2 Konsep Dasar Kecemasan	11
2.3 Konsep Dasar Ibu Hamil	15
2.4 Keaslian Penelitian	17
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS	
3.1 Kerangka Konsep	19
3.2 Hipotesis	19
BAB VI METODE PENELITIAN	
4.1 Desain Penelitian.....	20
4.2 Kerangka Kerja	21
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	22
4.4 Variabel.....	23
4.5 Definisi Operasional.....	24
4.6 Instrumen	25
4.7 Alat dan Bahan Penelitian	25
4.8 Waktu dan Tempat.....	26
4.9 Prosedur Pengumpulan Data.....	26
4.10 Teknik Analisa Data	26
4.11 Etika Penelitian	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
4.1 Definisi operasional.....	24
4.2 Interpretasi korelasi.....	26

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konsep.....	19
4.1 Kerangka Kerja.....	21

DAFTAR SIMBOL

%	: Persen
>	: lebih dari
<	: Kurang dari
α	: Alpha
ρ	: Rho
N	: Nilai yang di dapat
π	: Phi
β	: Beta
&	: dan

DAFTAR SINGKATAN

KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
RS	: Rumah Sakit
WHO	: <i>World Health Organization</i>
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SC	: <i>Sectio Caesaria</i>
ZSAS	: <i>Zung Self Anxiety Rating Scale</i>
HARS	: <i>Hamilton Anxiety Rating Scale</i>
Jatim	: Jawa Timur
Kemenkes	: Kementrian Kesehatan
RI	: Republik Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Permohonan menjadi responden
- Lampiran 2 : Pernyataan persetujuan (*Informed Consent*)
- Lampiran 3 : Kuesioner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecemasan merupakan salah satu masalah psikologis yang sering dialami pasien menjelang tindakan operasi, termasuk pada pasien pre operasi *sectio caesarea*. Kecemasan dapat muncul akibat rasa takut akan nyeri, risiko operasi, hingga kekhawatiran terhadap kondisi bayi yang akan dilahirkan. Jika tidak ditangani, kecemasan dapat memicu respon fisiologis seperti peningkatan tekanan darah, denyut jantung, serta gangguan pernapasan yang berdampak pada proses pembedahan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang akan menjalani operasi caesar mengalami kecemasan dengan tingkat sedang hingga berat (Astuti, 2022). Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi non-farmakologis yang efektif, sederhana, dan mudah diterapkan untuk mengurangi kecemasan.

Salah satu metode yang mulai dikembangkan adalah teknik relaksasi genggam jari. Metode ini termasuk terapi komplementer yang dapat membantu pasien mengendalikan emosi melalui stimulasi titik-titik energi pada jari tangan, sehingga menimbulkan rasa tenang dan nyaman. Studi terbaru mengungkapkan bahwa pasien pre operasi yang diberikan terapi genggam jari mengalami penurunan tingkat kecemasan yang signifikan dibandingkan kelompok kontrol tanpa intervensi (Rahman, 2023).

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2021), sekitar 10–15% ibu hamil di dunia mengalami kecemasan tinggi menjelang persalinan, terutama pada kasus yang memerlukan tindakan operasi seperti *sectio caesarea*. Di Indonesia, data Kementerian Kesehatan (2022) menunjukkan bahwa angka persalinan dengan *sectio caesarea* mencapai 17,6%, dan lebih dari 60% ibu yang akan menjalani operasi tersebut dilaporkan mengalami kecemasan sedang hingga berat. Sementara itu, di Jawa Timur, Dinas Kesehatan (2023) melaporkan bahwa prevalensi persalinan dengan operasi caesar mencapai 19,2%, dengan proporsi ibu yang mengalami kecemasan pra operasi masih cukup tinggi, yakni sekitar 58%. Data ini menegaskan bahwa kecemasan pada pasien pre operasi *sectio caesarea* merupakan masalah serius yang perlu ditangani melalui pendekatan farmakologis maupun non-farmakologis. Sedangkan berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada September 2025 di RS Prima Husada data ibu hamil yang persalinannya melalui *section caesaria* bulan Juni – Agustus 2025 sebanyak 117 pasien.

Penyebab kecemasan pada pasien pre operasi *sectio caesarea* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya informasi mengenai prosedur operasi, rasa takut terhadap nyeri, risiko komplikasi, hingga kekhawatiran akan kondisi bayi. Faktor psikologis seperti pengalaman persalinan sebelumnya, dukungan keluarga yang rendah, serta keterbatasan komunikasi dengan tenaga kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kecemasan (Sari, 2022). Selain itu, lingkungan rumah sakit yang asing bagi pasien sering kali menambah rasa tegang menjelang tindakan operasi.

Dampak dari kecemasan yang tidak dikelola dengan baik cukup serius, baik bagi ibu maupun bayi. Secara fisiologis, kecemasan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, serta gangguan pernapasan yang dapat mempersulit jalannya anestesi dan pembedahan. Pada aspek psikologis, kecemasan berlebihan dapat mengurangi kesiapan mental ibu dalam menghadapi operasi dan masa nifas. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa kecemasan pre operasi dapat meningkatkan risiko komplikasi intraoperatif dan memperlambat pemulihan pasca operasi (Putri, 2023).

Salah satu solusi untuk menurunkan kecemasan pada pasien pre operasi sectio caesarea adalah dengan menerapkan teknik relaksasi genggam jari. Metode ini termasuk terapi komplementer sederhana yang dapat dilakukan dengan cara menggenggam jari-jari tangan secara bergantian untuk menstimulasi titik energi yang berhubungan dengan kondisi emosional. Stimulasi ini membantu menyeimbangkan emosi, menimbulkan rasa tenang, dan mengurangi ketegangan psikologis (Astuti, 2022). Selain mudah dilakukan, teknik ini tidak membutuhkan alat khusus, aman, serta dapat dipraktikkan kapan saja sebelum operasi. Dengan penerapan teknik relaksasi genggam jari, pasien diharapkan lebih rileks, tingkat kecemasan menurun, dan kesiapan mental menghadapi operasi caesarea meningkat (Rahman, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar di RS Prima Husada Sukorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar di RS Prima Husada Sukorejo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar sebelum dilakukan teknik relaksasi genggam jari di RS Prima Husada Sukorejo.
2. Mengidentifikasi penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar sesudah dilakukan teknik relaksasi genggam jari di RS Prima Husada Sukorejo.
3. Menganalisis pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar di RS Prima Husada Sukorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam mengkaji efektivitas terapi komplementer, khususnya teknik relaksasi genggam jari, dalam menurunkan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesarea. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar ilmiah untuk mengembangkan penelitian lanjutan di bidang keperawatan maternitas maupun keperawatan medikal bedah, serta berkontribusi dalam pengembangan intervensi non-

farmakologis yang mendukung pelayanan kesehatan berbasis *evidence-based practice*.

1.4.2 Manfaat Bagi Responden

Bagi responden, penelitian ini memberikan manfaat berupa pengalaman langsung dalam praktik teknik relaksasi genggam jari yang sederhana, aman, dan mudah dilakukan untuk membantu menurunkan kecemasan menjelang operasi caesarea. Melalui penerapan teknik ini, pasien dapat merasa lebih rileks, tenang, serta lebih siap secara mental dalam menghadapi prosedur operasi. Dengan demikian, diharapkan kualitas kenyamanan pasien meningkat, risiko kecemasan berlebihan berkurang, dan proses pembedahan maupun pemulihan pasca operasi dapat berjalan lebih optimal.

1.4.3 Manfaat Bagi Insitusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan pendidikan atau penulisan bagi setiap institusi utamanya kalangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Teknik Relaksasi Genggam Jari

2.1.1 Definisi Relaksasi Genggam Jari

Relaksasi genggam jari (*finger hold relaxation*) adalah salah satu metode terapi komplementer yang bertujuan untuk memberikan ketenangan, mengurangi stres, serta menurunkan nyeri melalui teknik sederhana dengan menggenggam jari-jari tangan. Setiap jari dianggap memiliki keterhubungan dengan emosi tertentu, sehingga saat digenggam dan diberi tekanan lembut, emosi negatif dapat teralihkan dan tubuh menjadi lebih rileks (Hakim, 2023).

Metode ini termasuk ke dalam terapi non-farmakologis, artinya tidak menggunakan obat-obatan atau bahan kimia, melainkan memanfaatkan mekanisme tubuh alami untuk menciptakan ketenangan. Teknik ini dapat diterapkan secara mandiri oleh individu maupun dipandu oleh tenaga kesehatan. Selain itu, sifatnya yang sederhana dan tidak membutuhkan alat menjadikan relaksasi genggam jari mudah dipraktikkan oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia (Larasati, 2022).

2.1.2 Latar Belakang dan Sejarah

Teknik genggam jari pada awalnya berkembang dari praktik penyembuhan tradisional yang banyak digunakan di Jepang, dikenal dengan istilah *Jin Shin Jyutsu*. Konsep dasarnya adalah bahwa tubuh manusia memiliki aliran energi yang dapat tersumbat akibat stres, emosi negatif, atau sakit fisik.

Dengan menggenggam jari, energi tersebut dapat diseimbangkan kembali sehingga membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental (Saito, 2021).

Perkembangan terapi ini kemudian diadaptasi dalam dunia kesehatan modern sebagai metode relaksasi yang sederhana. Pada era keperawatan kontemporer, genggam jari mulai diperkenalkan sebagai salah satu bentuk terapi komplementer yang mendukung perawatan pasien, khususnya mereka yang mengalami kecemasan sebelum tindakan medis maupun pasca operasi (Asnaniar, 2023).

2.1.3 Landasan Teori Relaksasi Genggam Jari

Konsep dasar relaksasi genggam jari berhubungan erat dengan teori psikoneuroimunologi, yaitu keterkaitan antara pikiran, sistem saraf, dan sistem imun. Stres dan emosi negatif terbukti dapat memengaruhi kesehatan tubuh dengan menurunkan daya tahan dan meningkatkan risiko penyakit. Melalui teknik relaksasi, aktivitas sistem saraf simpatis (yang memicu stres) dapat ditekan, sehingga dominasi sistem saraf parasimpatis meningkat. Akibatnya, tubuh berada pada kondisi rileks, detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan hormon stres berkurang (Nguyen, 2024).

Selain itu, teori bioenergi juga mendukung konsep genggam jari. Tubuh diyakini memiliki pusat-pusat energi yang dapat diakses melalui titik tertentu pada tubuh, salah satunya adalah jari tangan. Dengan menggenggam jari, aliran energi dalam tubuh menjadi lebih lancar, sehingga berdampak positif pada kondisi emosional maupun fisik (Yusuf, 2025).

2.1.4 Mekanisme Fisiologis

Secara fisiologis, genggaman pada jari menstimulasi reseptor sensorik yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak. Respon otak terhadap stimulasi ini adalah

dengan menurunkan aktivitas simpatik dan meningkatkan aktivitas parasimpatik. Kondisi ini memicu pelepasan hormon-hormon yang berperan dalam relaksasi, antara lain:

1. Endorfin, yaitu zat alami tubuh yang berfungsi sebagai pereda nyeri.
2. Enkephalin, yaitu neuropeptida yang memberikan efek nyaman.
3. Melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur dan membantu menciptakan rasa tenang.

2.1.5 Mekanisme Psikologis

Selain efek fisiologis, genggam jari juga memiliki dampak psikologis. Saat seseorang fokus menggenggam jari dan mengatur pernapasan, perhatian teralihkan dari pikiran-pikiran negatif atau rasa nyeri. Proses ini disebut sebagai *mindfulness relaxation*, yaitu kondisi di mana pikiran lebih terfokus pada saat ini sehingga mengurangi kecemasan dan kekhawatiran berlebih (Elnosary, 2024). Teknik ini juga memberi efek sugestif. Pasien yang percaya pada manfaat relaksasi genggam jari cenderung mengalami perasaan tenang lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek psikologis sangat berperan dalam keberhasilan metode ini.

2.1.6 Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan relaksasi genggam jari dapat dijelaskan sebagai berikut (Asnaniar, 2023):

1. Duduk atau berbaring pada posisi nyaman.
2. Tarik napas dalam melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut.
3. Genggam ibu jari tangan dengan tangan yang lain, tahan selama 2–3 menit.
4. Lanjutkan pada jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking dengan cara yang sama.
5. Selama menggenggam jari, fokus pada pernapasan dan lepaskan pikiran negatif.

6. Setelah semua jari digenggam, tarik napas panjang terakhir dan rasakan tubuh menjadi lebih rileks.

2.1.7 Manfaat Relaksasi Genggam Jari

Banyak penelitian terkini membuktikan manfaat teknik ini, antara lain:

1. Menurunkan kecemasan pada pasien sebelum tindakan medis (Hakim, 2023).
2. Mengurangi nyeri pasca operasi sehingga mempercepat proses pemulihan (Nguyen, 2024).
3. Meningkatkan kualitas tidur melalui peningkatan hormon melatonin (Poltekkes Malang, 2023).
4. Mengendalikan emosi seperti marah, sedih, dan panik (Elnosary, 2024).
5. Meningkatkan kontrol diri dan rasa percaya diri (Yusuf, 2025).

2.1.8 Keunggulan Relaksasi Genggam Jari

Teknik ini memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya:

1. Sederhana dan praktis: bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.
2. Tidak membutuhkan alat atau biaya: berbeda dengan terapi lainnya yang membutuhkan fasilitas khusus.
3. Aman dan tanpa efek samping: cocok untuk berbagai kelompok usia.
4. Bersifat komplementer: dapat digunakan berdampingan dengan terapi medis utama.

2.1.9 Keterbatasan Relaksasi Genggam Jari

Meskipun memiliki banyak manfaat, teknik ini juga memiliki keterbatasan. Relaksasi genggam jari tidak dapat menggantikan terapi medis utama. Efeknya juga berbeda-beda pada tiap individu, tergantung pada tingkat stres, sugesti, dan konsistensi latihan. Selain itu, beberapa pasien dengan kondisi medis serius mungkin membutuhkan pendampingan tenaga kesehatan agar pelaksanaannya lebih efektif (Rasquin, 2022).

2.1.10 Relevansi dengan Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, relaksasi genggam jari banyak digunakan untuk mengurangi kecemasan pasien yang akan menjalani tindakan medis invasif, seperti operasi, kemoterapi, atau prosedur perawatan yang menimbulkan rasa takut. Perawat dapat mengajarkan teknik ini kepada pasien sebagai salah satu bentuk intervensi non-farmakologis. Dengan demikian, relaksasi genggam jari dapat meningkatkan kenyamanan pasien serta mendukung peran perawat dalam memberikan perawatan holistik (Yanti, 2023).

2.2 Konsep Kecemasan

2.2.1 Pengertian

Kecemasan adalah kondisi psikologis seseorang yang penuh dengan rasa takut dan khawatir, dimana perasaan takut dan khawatir akan sesuatu hal yang belum pasti akan terjadi. Kecemasan berasal dari bahasa Latin (*anxius*) dan dari bahasa Jerman (*anst*), yaitu suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif dan rangsangan fisiologis (Widyastuti, 2019).

2.2.2 Tingkat Kecemasan

Semua orang pasti mengalami kecemasan pada derajat tertentu, Menurut Febriyanti, Sutresna and Prihandini (2020), mengidentifikasi empat tingkatan kecemasan, yaitu :

a. Kecemasan Ringan

Kecemasan ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kecemasan ini dapat memotivasi belajar menghasilkan pertumbuhan serta kreatifitas. Tanda dan gejala antara lain: persepsi dan perhatian meningkat, waspada, sadar akan stimulus internal dan eksternal, mampu mengatasi masalah secara efektif serta terjadi kemampuan belajar. Perubahan fisiologi ditandai dengan gelisah, sulit tidur, hipersensitif terhadap suara, tanda vital dan pupil normal.

b. Kecemasan Sedang

Kecemasan sedang memungkinkan seseorang memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga individu mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Respon fisiologi : sering nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, mulut kering, gelisah, konstipasi. Sedangkan respon kognitif yaitu lahan persepsi menyempit, rangsangan luar tidak mampu diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatiaannya.

c. Kecemasan Berat

Kecemasan berat sangat mempengaruhi persepsi individu, individu cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berfikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Tanda dan gejala dari kecemasan berat yaitu : persepsinya sangat kurang, berfokus pada hal yang detail, rentang perhatian sangat terbatas, tidak dapat berkonsentrasi atau menyelesaikan masalah, serta tidak dapat belajar secara efektif. Pada tingkatan ini individu mengalami sakit kepala, pusing, mual, gemetar, insomnia, palpitasi, takikardi, hiperventilasi, sering buang air kecil maupun besar, dan diare. Secara emosi individu mengalami ketakutan serta seluruh perhatian terfokus pada dirinya.

d. Panik

Pada tingkat panik dari kecemasan berhubungan dengan terperangah, ketakutan, dan teror. Karena mengalami kehilangan kendali, individu yang mengalami panik tidak dapat melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Panik menyebabkan peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, kehilangan pemikiran yang rasional. Kecemasan ini tidak sejalan dengan kehidupan, dan

jika berlangsung lama dapat terjadi kelelahan yang sangat bahkan kematian.

Tanda dan gejala dari tingkat panik yaitu tidak dapat fokus pada suatu kejadian.

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan

Kecemasan sering kali berkembang selama jangka waktu dan sebagian besar tergantung pada seluruh pengalaman hidup seseorang. Peristiwa - peristiwa atau situasi khusus dapat mempercepat munculnya serangan kecemasan. Menurut Oktarini and Prima (2021), ada beberapa faktor yang menunjukkan reaksi kecemasan, diantaranya yaitu :

a. Lingkungan

Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berfikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan kerja. Sehingga individu tersebut merasa tidak aman terhadap lingkungannya.

b. Emosi

Kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal ini, terutama jika dirinya menekan rasa marah atau frustrasi dalam jangka waktu yang sangat lama

c. Fisik

Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan semasa remaja dan sewaktu terkena suatu penyakit. Selama ditimpa kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim muncul, dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Kecemasan timbul karena adanya ancaman atau bahaya yang tidak nyata dan sewaktu-waktu terjadi pada diri

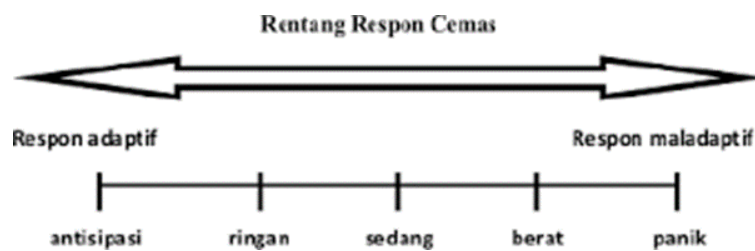
individu serta adanya penolakan dari masyarakat menyebabkan kecemasan berada di lingkungan yang baru dihadapi.

2.2.4 Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Operasi SC

Kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil yang akan menjalani operasi Caesarean Section (SC) adalah hal yang wajar. Momen seperti ini seringkali penuh dengan perasaan campuran, termasuk kebahagiaan dan antusiasme atas kelahiran bayi yang akan datang, namun juga kekhawatiran dan ketidakpastian terkait dengan prosedur operasi tersebut. Ibu hamil mungkin merasa cemas karena takut akan rasa sakit, risiko komplikasi, atau bahkan perasaan tidak dapat mengontrol situasi. Semua perasaan ini adalah respons alami terhadap situasi yang berpotensi menegangkan, dan penting untuk diakui dan dipahami (Nibaho, 2021).

Penting untuk ibu hamil dan tim medis yang merawatnya untuk berkomunikasi secara terbuka tentang prosedur SC, risiko yang terlibat, dan opsi perawatan yang tersedia. Mendengarkan kekhawatiran ibu hamil, memberikan penjelasan yang jelas, dan memberikan dukungan emosional yang kuat dapat membantu mengurangi kecemasan mereka. Selain itu, memiliki pasangan, keluarga, atau teman yang mendukung yang hadir selama prosedur dapat memberikan rasa nyaman dan dukungan tambahan kepada ibu hamil. Penting juga untuk diingat bahwa tim medis yang terampil dan berpengalaman selalu berusaha untuk memberikan perawatan terbaik untuk ibu dan bayi, menjadikan keselamatan dan kesejahteraan mereka sebagai prioritas utama (Marzuki, 2021).

2.2.5 Rentang Respon Kecemasan



Gambar 2.1 Rentang Respon Kecemasan
(Sumber: Stuart, 2023)

1. Respon Adaptif

Hasil yang positif akan didapatkan jika individu dapat menerima dan mengatur kecemasan. Kecemasan dapat menjadi suatu tantangan, motivasi yang kuat untuk menyelesaikan masalah, dan merupakan sarana untuk mendapatkan penghargaan yang tinggi. Strategi adaptif adalah strategi yang biasanya digunakan seseorang untuk mengatur kecemasan antara lain dengan berbicara kepada orang lain, menangis, tidur, latihan, dan menggunakan teknik relaksasi.

2. Respon Mal Adaptif

Ketika kecemasan tidak dapat diatur, individu menggunakan mekanisme koping yang disfungsi dan tidak berkesinambungan dengan yang lainnya. Koping maladaptif mempunyai banyak jenis termasuk perilaku agresif, bicara tidak jelas, isolasi diri, banyak makan, konsumsi alkohol, berjudi, dan penyalahgunaan obat terlarang.

2.2.6 Alat Ukur Kecemasan

Menurut Mc Dowel dalam (Swarjana, 2022) menyebutkan Alat ukur kecemasan meliputi :

1. *Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)*

Alat ukur kecemasan ini diciptakan oleh Max Hamilton yang bertujuan

untuk mengukur gangguan klinikal dan gejala kecemasan. Alat ukur HARS telah menjadi standard dalam pengukuran kecemasan. Penggunaan alat ukur HARS ditujukan untuk orang yang telah didiagnosis gangguan kecemasan, bukan untuk mendiagnosa orang dengan diagnosis yang lain. Kuisisioner HARS terdiri dari 13 kategori gejala kecemasan dan 1 kategori perilaku. Kategori gejala kecemasan dibagi menjadi 6 kategori psikologis dan 7 kategori fisiologis. Rentang nilai skala HARS adalah 0-56. Nilai validitas dari skala pengukuran kecemasan ini adalah 0,77 dan nilai reliabilitasnya adalah 0,83

2. *Zung Self-Anxiety Rating Scale (ZSAS/SAS)*

Alat ukur ini adalah penilaian kecemasan pada pasien dewasa yang dirancang oleh William W. KZung dalam (Ramadhani S, 2022), dikembangkan berdasarkan gejala kecemasan dalam *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders (DSM-II)*.

Terdapat 20 pernyataan, dimana setiap pernyataan tersedia empat pilihan jawaban yaitu tidak pernah, kadang-kadang, cukup sering, dan sering/ selalu. Dari 20 pernyataan terdapat 15 pernyataan ke arah peningkatan kecemasan yaitu pernyataan nomer (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, dan 20) dan 5 pernyataan ke arah penurunan kecemasan yaitu pernyataan nomer (5, 9, 13, 17 dan 19).

Rentang penilaian 20 sampai 80, dengan pengelompokan antara lain:

Skor 20-40 : normal/tidak cemas.

Skor 45-59: kecemasan ringan.

Skor 60-74: kecemasan sedang.

Skor 75-80:kecemasan berat.

3. *Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS)*

Alat ukur ini dikembangkan oleh Janet Taylor pada tahun 1953. Terdiri dari 50 item pernyataan yang mengukur aspek afektif, kognitif dan fisiologis dari manifestasi kecemasan. Dalam pengukuran skala kecemasan ini setiap responden diminta untuk menuliskan jawaban “ya” atau “tidak” sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Hasil uji validitas menunjukkan nilai 0,91 dan uji reliabilitasnya adalah 0,86.

4. *State Trait Anxiety Inventory (STAI)*

Alat ukur dikembangkan oleh Charles D. Spielberger pada tahun 1983. STAI terdiri dari 40 item yang terbagi ke dalam dua formulir kecemasan, yaitu formulir X untuk kategori *state anxiety* dan formulir Y untuk kategori *trait anxiety*. Setiap formulirnya memiliki 20 item pernyataan dimana setiap itemnya memiliki empat alternatif jawaban dari 1 sampai dengan 4. Skala pengukuran *State-Trait Anxiety Inventory (STAI)* memiliki empat poin skala Likert.

Dalam mengisi kuesioner, responden diharuskan untuk memilih salah satu alternatif jawaban pada setiap item. Untuk dimensi *state anxiety*, responden diharuskan untuk memilih salah satu alternatif jawaban sesuai dengan apa yang ia rasakan pada saat ini. Alternatif jawaban yang dapat dipilih diantaranya adalah Tidak Sama Sekali

(TSS), Agak/Sedikit (A/S), Cukup/Sedang (C/S), dan Sangat Banyak (SB). Sedangkan untuk dimensi *trait anxiety*, responden diharuskan untuk memilih salah satu alternatif jawaban sesuai dengan perasaan yang seringkali atau pada umumnya ia rasakan. Alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden diantaranya adalah Tidak Pernah (TP), Kadang-kadang (KK), Sering (S), dan Selalu (SL). Instrumen ini telah diuji validitas dengan interval nilai 0,88 dan uji reliabilitas dengan hasil nilai alpha untuk *state anxiety* adalah 0,93 dan untuk *trait anxiety* yaitu 0,91.

2.3 Konsep Dasar Ibu Hamil

2.3.1 Pengertian

Ibu hamil adalah seseorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan merupakan suatu proses fisiologik yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum, tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu atau sampai 42 minggu (Astapani dkk., 2020).

2.3.2 Periode Kehamilan

Menurut Sunarti S and Kartini (2019), Periode kehamilan dibedakan menjadi III trimester yaitu :

1. Masa kehamilan trimester I Masa kehamilan trimester I yaitu 0-12 minggu, pada awal kehamilan (trimester I) sering terjadinya mual dan muntah yang

dialami oleh wanita atau sering disebut morning sickness. Mual dan muntah pada awal kehamilan berhubungan dengan perubahan kadar hormonal pada tubuh wanita hamil. Pada kehamilan trimester I biasanya terjadi peningkatan berat badan yang tidak berarti yaitu sekitar 1-2 kg.

2. Masa kehamilan trimester II yaitu 13-27 minggu

3. Masa trimester III yaitu 28-40 minggu, pada masa trimester II dan III terjadi penambahan berat badan yang ideal selama kehamilan. Ibu hamil harus memiliki berat badan yang normal karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi akan menyebabkan keguguran, anak lahir prematur, berat badan bayi rendah, gangguan rahim pada waktu persalinan, dan pendarahan setelah persalinan.

2.3.3 Tanda & Bahaya pada kehamilan trimester I-III

Tanda-tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode antenatal, yang apabila tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu. Macam-macam tanda bahaya kehamilan diantaranya perdarahan per vaginam, sakit kepala yang hebat, masalah penglihatan, bengkak pada muka dan tangan, nyeri perut yang hebat, gerakan janin berkurang atau menghilang, demam, mual muntah yang berlebihan, keluar cairan banyak per vaginam secara tiba-tiba (keluar air ketuban sebelum waktunya) (Inayah, 2020).

2.3.4 Persalinan Operasi SC

Persalinan melalui operasi Caesarean Section (SC) adalah prosedur medis yang dilakukan ketika persalinan alami tidak memungkinkan atau tidak

aman bagi ibu atau bayi. Selama SC, dokter melakukan sayatan pada dinding perut dan rahim untuk mengeluarkan bayi. Meskipun ini adalah prosedur bedah, operasi SC umumnya dianggap aman dan dapat menjadi pilihan terbaik dalam situasi tertentu, seperti ketika ada komplikasi dalam kehamilan atau persalinan. Tim medis yang terampil dan terlatih bekerja keras untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi, sambil memberikan perawatan yang terbaik selama prosedur ini.

2.3.5 Faktor Penyebab Persalinan SC

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beberapa faktor penyebab persalinan melalui operasi Caesarean Section (SC) antara lain:

1. Distosia (kesulitan) dalam proses persalinan alami, seperti posisi bayi yang tidak tepat, persalinan lambat, atau ketidakmampuan rahim untuk berkontraksi dengan cukup kuat.
2. Kelainan pada janin, seperti presentasi bokong (bayi dengan kepala berada di atas) atau masalah kesehatan janin yang memerlukan pengiriman cepat.
3. Komplikasi kehamilan, seperti preeklampsia (tekanan darah tinggi selama kehamilan), diabetes gestasional, atau masalah plasenta.
4. Riwayat operasi SC sebelumnya.
5. Pilihan ibu atau keluarga untuk menjalani SC, terutama jika ada kekhawatiran terkait dengan persalinan alami.
6. Usia ibu yang lebih tua, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi selama persalinan alami.

Faktor-faktor medis lainnya, seperti kelainan anatomi panggul ibu yang menghalangi persalinan alami

2.4 Keaslian Penelitian

No	Nama & Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmawati (2021). Pengaruh Teknik Relaksasi Genggam Jari terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan pada Ibu Pre Operasi Sectio Caesarea di RSUD Dr. Soetomo Surabaya	Desain: Pre-eksperimen dengan one group pretest-posttest design. Populasi: Ibu hamil pre operasi caesar. Sampel: 30 responden. Teknik sampling: Purposive sampling. Analisis data: Wilcoxon Signed Rank Test.	Univariat: Sebelum intervensi mayoritas responden mengalami kecemasan sedang (70%), setelah intervensi sebagian besar mengalami kecemasan ringan (80%). Bivariat: Ada pengaruh signifikan teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan kecemasan ($p = 0.000 < 0.05$).
2	Lestari & Anjani (2022). Efektivitas Relaksasi Genggam Jari terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Pre Sectio Caesarea di RSUD dr. Moewardi Surakarta	Desain: Quasi eksperimen dengan pretest-posttest control group design. Populasi: Ibu hamil yang akan menjalani operasi caesar. Sampel: 40 orang (20 kelompok intervensi, 20 kontrol). Teknik sampling: Consecutive sampling. Analisis data: Paired t-test dan Independent t-test.	Univariat: Rata-rata skor kecemasan sebelum intervensi 26,8 turun menjadi 14,2 setelah intervensi. Bivariat: Terdapat perbedaan bermakna antara kelompok intervensi dan kontrol ($p = 0.001$).
3	Nugraheni et al. (2023). Pengaruh Terapi Relaksasi Genggam Jari terhadap Penurunan Kecemasan pada	Desain: Pre-eksperimen dengan one group pretest-posttest design.	Univariat: Sebelum terapi sebagian besar mengalami kecemasan sedang (68%), setelah terapi sebagian besar menjadi kecemasan ringan (84%). Bivariat: Ada

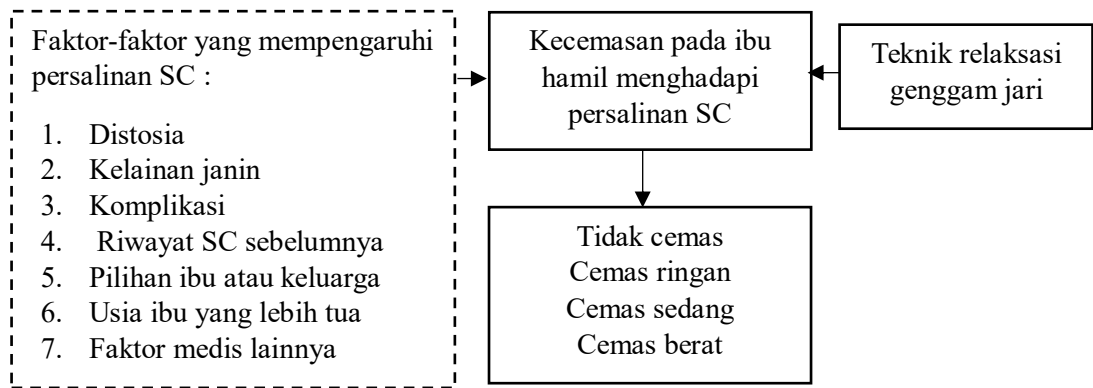
	Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea di RSUD Banyumas	Populasi: Pasien pre operasi caesar. Sampel: 25 responden. Teknik sampling: Accidental sampling. Analisis data: Wilcoxon Signed Rank Test.	pengaruh signifikan antara terapi genggam jari dengan penurunan kecemasan ($p = 0.002$).
--	---	--	--

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah tahap paling penting dalam suatu penelitian, konsep adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat di komunikasikan dan dapat membentuk suatu teori yang menjelaskan suatu keterkaitan variabel (Nursalam, 2020).



Keterangan :

- : diteliti
□ : tidak diteliti
→ : mempengaruhi

Gambar 3.1 : Kerangka konseptual penelitian pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar di RS Prima Husada Sukorejo

3.2 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (Nursalam, 2020).

H₁: Ada pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar di RS Prima Husada Sukorejo

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pra eksperimental karena membutuhkan pembuktian dan pengembangan ilmu yang ada di lapangan melalui suatu intervensi dan observasi dari intervensi yang diberikan (Nursalam, 2020). Rancangan penelitian merupakan sesuatu strategi penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan sebelum perencanaan akhir pengumpulan data (Nursalam, 2020). Penelitian ini menggunakan one group *pre test – post test design*, yaitu mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok yang diberikan perlakuan. Kelompok perlakuan diobservasi sebelum dilakukan intervensi, dan kemudian diobservasi lagi setelah dilakukan intervensi (Nursalam, 2020).

Tabel 4.1 Rancangan *pre test – post test group design*

Subjek	Pra	Perlakuan	Post
S	O	I	OI

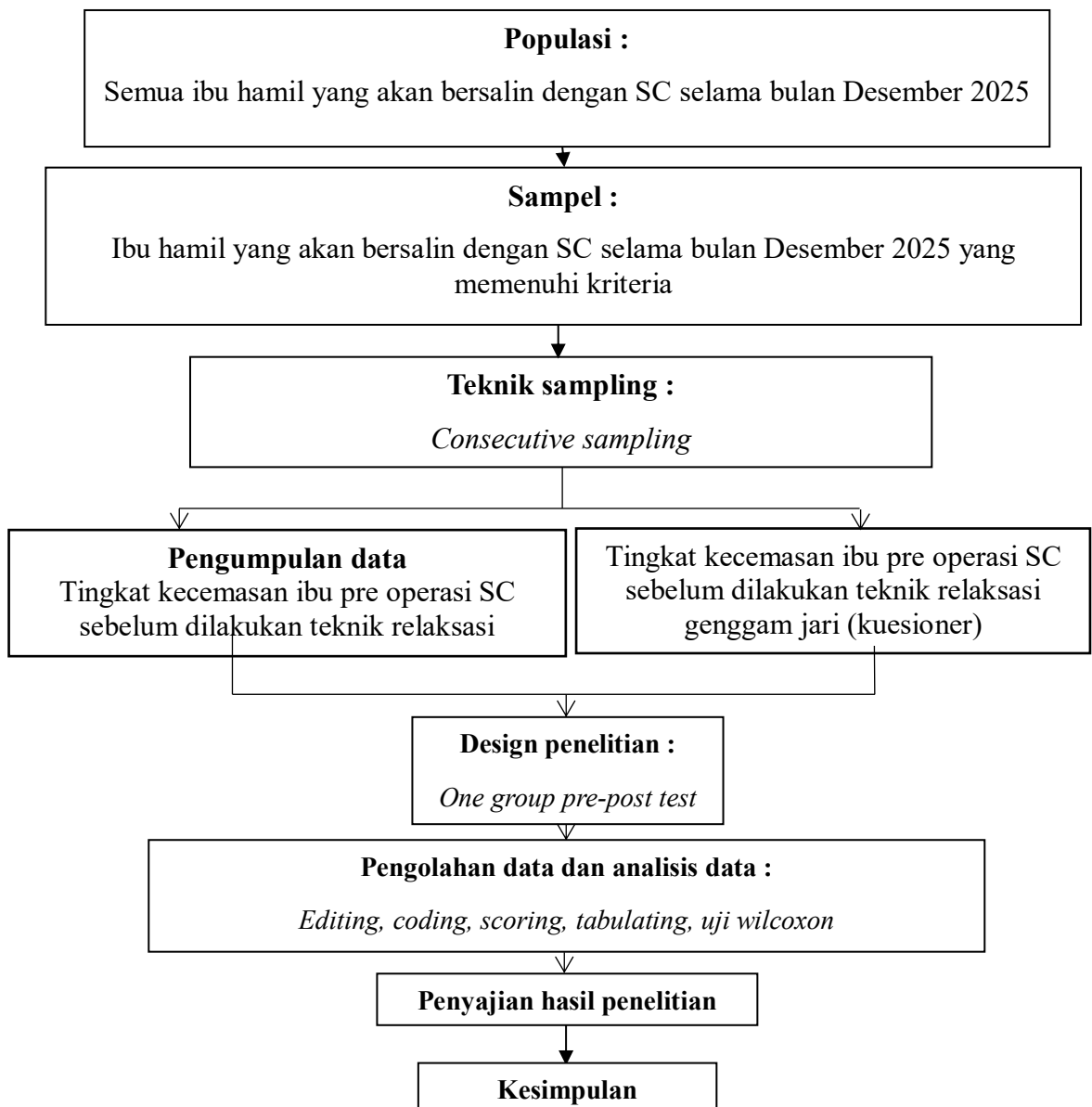
Keterangan :

- S : Subjek perlakuan
- O : Kecemasan pasien pre operasi SC sebelum dilakukan teknik relaksasi genggam jari
- I : Intervensi teknik relaksasi genggam jari
- OI : Kecemasan pasien pre operasi SC sesudah dilakukan teknik relaksasi genggam jari

4.2 Kerangka Kerja Penelitian (frame work)

Kerangka kerja adalah bagian kerja terhadap rancangan kegiatan penelitian yang akan di lakukan meliputi siapa yang akan diteliti (subyek penelitian), variabel yang akan diteliti dan variabel yang akan mempengaruhi dalam penelitian (Nursalam, 2020).

Adapun kerangka kerja sebagai berikut:



Gambar 4.1 : Kerangka kerja pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar di RS Prima Husada Sukorejo

4.3 Populasi, Sampel Dan Sampling

4.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah merupakan subjek (misalnya manusia: klien) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. (Nursalam, 2020). Wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang menjadi kuantitas dan karakter tertentu yang telah ditentukan peneliti untuk ditarik kesimpulan. (Donsu, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil menghadapi operasi SC selama bulan Desember 2025

4.3.2. Sampel

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian sebagai sampling. (Nursalam, 2020). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang menghadapi operasi SC selama bulan Desember 2025 yang memenuhi kriteria. Yaitu 1) Pasien pre op SC yang mengalami kecemasan, 2) Dapat berkomunikasi dengan baik, sadar penuh dan mampu mengikuti instruksi tehnik relaksasi, 3) Bersedia menjadi responden, 4) Tidak memiliki komplikasi kehamilan berat seperti preeklampsia berat, perdarahan atau gawat janin, 5) Tidak mengalami nyeri berat atau ketidaknyamanan yang mengganggu proses relaksasi, 6) Dapat menyelesaikan sesi relaksasi

4.3.3. Sampling

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel. Agar memperoleh sampel yang benar benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. (Nursalam, 2020). Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan jenis *consecutive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan cara memilih semua subjek penelitian yang memenuhi kriteria sampel secara berturut-turut sampai sampel yang dibutuhkan terpenuhi (Nursalam, 2020). Artinya setiap pasien yang datang dan memenuhi syarat akan langsung dimasukkan sebagai sampel selama periode penelitian berlangsung.

4.4 Variabel penelitian

4.4.1 Variabel independen (bebas)

Variabel yang mempengaruhi atau nilainya menentukan variabel lain. (Nursalam, 2020). Variabel independen dalam penelitian ini adalah teknik relaksasi genggam jari

4.4.2 Variabel dependen (terikat)

Variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan oleh variabel lain. Dengan kata lain, variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan

4.5 Definisi Operasional

Merupakan variabel operasional yang dilakukan penelitian berdasarkan karakteristik yang diamati. Ditentukan berdasarkan pada parameter ukuran dalam penelitian serta mengungkapkan variabel dari skala pengukuran masing masing variabel (Nursalam, 2020).

Tabel 4.1 Definisi operasiaonal pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar di RS Prima Husada Sukorejo

Variabel	Definisi operasional	Parameter	Alat ukur	Skala	Kriteria
Variabel independen: teknik relaksasi genggam jari	Metode relaksasi sederhana dengan cara menggenggam dan menekan lembut setiap jari tangan secara bergantian untuk membantu menyeimbangkan emosi, menurunkan ketegangan, dan mengurangi kecemasan	1. Frekuensi pelaksanaan 2. Durasi setiap sesi 3. Urutan jari 4. Tekanan genggaman 5. Pola pernapasan 6. Konsentrasi dan ketenangan 7. Respons fisiologis 8. Respons psikologis	SOP		
Variabel dependen: Tingkat kecemasan	Kondisi psikologis seseorang yang penuh dengan rasa takut dan khawatir, dimana perasaan takut dan khawatir akan sesuatu hal yang belum pasti akan terjadi (Widyastuti, 2019)	Gejala kecemasan menurut Zung Rating Anxiety Scale yang terdiri dari 20 gejala	Kuesioner	Ordinal	1. Normal/Tidak cemas (20-39) 2. Cemas ringan (40-59) 3. Cemas sedang (60-74) 4. Cemas berat (75-80)

4.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dan diperlukan dalam sebuah penelitian. Instrumen ini dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, tes, atau metode lainnya yang dirancang untuk mengumpulkan data

secara sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Nursalam, 2020). Instrumen dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuisisioner digunakan untuk mendapatkan data demografi terdiri dari usia ibu, pendidikan terakhir, pekerjaan, riwayat kehamilan dan riwayat operasi serta mengukur tingkat kecemasan. Kuesioner pengukuran kecemasan menggunakan kuesioner *Zung Self Rating Anxiety Scale*. Sedangkan perlakuan teknik relaksasi genggam jari acuan yang digunakan berdasarkan SOP.

4.7 Waktu dan Tempat Penelitian

4.8.1 Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2025

4.8.2 Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RS Prima Husada Sukorejo

4.8 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan proses pengumpulan karakteristik subyek diperlukan yang akan dilakukan pengambilan data penelitian. (Nursalam, 2020).

Proses pada pengambilan data penelitian ini adalah :

- a. Mengurus surat pengantar dari kampus STIKes Husada Jombang untuk pengambilan data
- b. Mengurus perizinan pengambilan data kepada direktur RS Prima Husada Sukorejo
- c. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian
- d. Mengisi semua daftar pertanyaan dalam kuesioner

- e. Mengolah data dan menyusun laporan hasil penelitian.

4.9 Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data adalah merupakan cara mengelola data agar dapat disimpulkan atau diinterpretasikan menjadi informasi (Donsu, 2017).

1. *Editing*

Editing adalah upaya memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau yang dikumpulkan (Donsu, 2017). *Editing* pada penelitian ini dilakukan dengan melihat kembali data yang ada apakah ada kesalahan atau kosong sehingga perlu dilakukan perbaikan dan melengkapi data yang kosong.

2. *Coding*

Coding adalah memberikan identitas pada masing masing angket kuisioner sesuai nomer untuk responden.

Usia :

17-25 tahun = 1

26-35 tahun = 2

36-45 tahun = 3

>45 tahun = 4

Pendidikan :

Tidak sekolah = 1

SD = 2

SMP = 3

SMA = 4

Perguruan tinggi = 5

Pekerjaan :

Tidak bekerja = 1

Petani = 2

Wiraswasta = 3

PNS = 4

Lainnya = 5

Kehamilan ke :

Pertama = 1

Ke dua = 2

Ke tiga = 3

Ke empat = 4

Ke lima = 5

Riwayat operasi :

Belum pernah = 1

Pernah = 2

Tingkat kecemasan :

Normal/Tidak cemas = 1

Cemas ringan = 2

Cemas sedang = 3

Cemas berat = 4

3 Scoring

Untuk mengukur tingkat kecemasan menggunakan instrumen kuisioner yang berisi pernyataan dan penyekorannya.

Untuk pernyataan positif, jika responden menjawab :

Tidak pernah maka diberi skor 1

Kadang-kadang maka diberi skor 2

Cukup sering maka diberi skor 3

Sering maka diberi skor 4

Untuk pernyataan negatif, jika responden menjawab :

Tidak pernah maka diberi skor 4

Kadang-kadang diberi skor 3

Cukup sering diberi skor 2

Sering diberi skor 1

Tingkat kecemasan :

Normal/ Tidak cemas : skor 20-39

Cemas ringan : skor 40-59

Cemas sedang : skor 60-74

Cemas berat : skor 75-80

4. *Tabulating*

Tabulating memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam tabel master atau *data base computer*, kemudian membuat distribusi frekuensi atau bias juga dengan menggunakan tabel kontigensi. (Wiratna, 2022).

Menurut (Arikunto, 2023), untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi, digunakan kategori persentase. Setelah kategorinya diketahui kemudian hasilnya di presentase dengan kriteria :

a. 0% : tidak ada/ tidak satupun

- b. 1%-25% : sebagian kecil
- c. 26%-49% : hampir setengah
- d. 50% : setengah
- e. 51%-75% : sebagian besar
- f. 76%-99% : hampir seluruhnya
- g. 100% : seluruhnya

5. Analisis Data

Untuk mengetahui adanya pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi caesar di RS Prima Husada Sukorejo menggunakan uji *Wilcoxon* dengan perangkat lunak computer program *statistical product and service solution* (SPSS) 24 *for windows* dengan derajat kemaknaan $\alpha = 0,05$. Jika $p < \alpha$ maka hipotesis (H1) diterima yang artinya ada pengaruh relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre op SC. Jika $p > \alpha$ maka hipotesis (H1) ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh relaksasi genggam jari terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre op SC.

4.10 Etika penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan izin kepada direktur RS Prima Husada Sukorejo

1. Lembar persetujuan menjadi responden (*informed consent*)

Lembar persetujuan diberikan kepada subyek yang akan diteliti, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan riset yang dilakukan serta dampak

yang mungkin terjadi selama dan sesudah pengumpulan data. Jika bersedia diteliti, maka harus menandatangani lembar persetujuan tersebut dan bila menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak haknya.

2. *Anonimity*

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak mencantumkan namanya pada lembar pengumpulan data, cukup dengan memberikan nomor kode masing masing lembar tersebut.

3. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh subyek dijamin oleh peneliti, penyajian data hasil penelitian hanya ditampilkan dalam forum akademik, lembar persetujuan terlampir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2023) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian*, Rineka Cipta.
- Asnaniar, R. (2023). Efektivitas teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan kecemasan pasien pre operasi. *Jurnal Keperawatan Nusantara*, 8(2), 155–164.
- Astuti, R. (2022). Efektivitas teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan kecemasan pada pasien pre operasi. *Jurnal Keperawatan Holistik*, 14(2), 65–73.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. (2023). Profil kesehatan Jawa Timur tahun 2023. Surabaya: Dinkes Jatim.
- Donsu, J. D. . (2017) *Metodologi Penelitian Keperawatan dan Kesehatan*, Salemba Medika.
- Elnosary, A. (2024). Finger hold relaxation as a complementary therapy for anxiety and panic disorders: A clinical review. *International Journal of Mental Health Nursing*, 33(1), 88–97.
- Hakim, A. (2023). Relaksasi genggam jari sebagai terapi komplementer untuk mengurangi nyeri dan stres emosional. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 45–53.
- Indrayani, T., & Sumarni, W. (2019). Efektivitas Afirmasi Tenaga Kesehatan Pada Tingkat Kecemasan Ibu Bersalin Multipara Di RSUD Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018/2019. *Ilmu dan Budaya*, 41(63).
- Irawati, A. (2020). *Korelasi Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Ibu Hamil Sebelum Operasi Sectio Caesarea di RSUD Karanganyar* (Doctoral dissertation, Universitas Kusuma Husada Surakarta).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil kesehatan Indonesia 2022. Jakarta: Kemenkes RI.
- Larasati, D. (2022). Manajemen stres melalui terapi relaksasi genggam jari pada remaja. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 4(2), 102–111.
- Lestari, A., & Arafah, E. H. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Preoperasi Sectio Caesarea Di Rsud Lamaddukelleng. *JHNMSA ADPERTISI JOURNAL*, 1(2), 20-41.

- Marzuki, M. S., & Mustaqim, M. H. (2021). Gambaran Tingkat Kecemasan Persiapan Operasi Sectio Caesaria Pada Ibu Hamil. *Jurnal Sains Riset*, 11(2), 269-280.
- Naibaho, R. M. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kecemasan Ibu Pre Operasi Sectio Caesarea (Sc) Di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dentist)*, 16(3), 532-538.
- Nguyen, T. (2024). Neurophysiological effects of finger relaxation therapy on post-surgical patients. *Journal of Holistic Nursing*, 42(3), 231–240.
- Novianti, L., & Mato, R. (2019). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecemasan Ibu Dalam Menghadapi Persalinan Sectio Caesarea Di Rsia Sitti Khadijah I Makassar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 14(4), 364-368.
- Nua, E. N., Ringgi, M. S. I. N., & Angelorum, M. R. (2021). Pengaruh Komunikasi Terapeutik Perawat Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea Di RSUD dr. TC Hillers Maumere. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat*, 6(2).
- Nursalam, N. (2020) 'Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan - Ners Unair Repository', 2020.
- Putri, A. (2023). Dampak kecemasan pre operasi terhadap kondisi fisiologis dan pemulihan pasien sectio caesarea. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 11(1), 44–52.
- Rahman, F. (2023). Pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap tingkat kecemasan pasien menjelang tindakan operasi. *Jurnal Psikologi Kesehatan*, 9(3), 101–109.
- Rasquin, L. (2022). Complementary relaxation techniques in pain management: A review. *Women's Health Reports*, 3(2), 201–210.
- Saito, H. (2021). Jin Shin Jyutsu and finger hold relaxation: Traditional roots and modern applications. *Asian Journal of Complementary Medicine*, 7(1), 59–67.
- Sari, D. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kecemasan ibu hamil menjelang operasi caesarea. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(1), 55–62.
- Wiratna, S. (2022) 'Metodologi penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami', *Pt.Pustaka Baru*.
- World Health Organization. (2021). Improving maternal and newborn health and survival and reducing stillbirth. Geneva: WHO.

- Yanti, D. (2023). Peran perawat dalam penerapan teknik relaksasi genggam jari untuk meningkatkan kenyamanan pasien. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 16(2), 134–142.
- Yusuf, M. (2025). Efektivitas finger hold relaxation terhadap pengendalian emosi pada pasien penyakit kronis. *Jurnal Kesehatan Holistik*, 13(1), 22–31.

SOP DAN KUESIONER**PENGARUH TEKNIK RELAKSASI GENGAM JARI TERHADAP
PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI
CAESAR DI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO**

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang sesuai !

Usia :Tahun

Pendidikan : ☐ Tidak sekolah
☐ SD
☐ SMP
☐ SMA
☐ Perguruan Tinggi

Pekerjaan : ☐ Tidak bekerja
☐ Petani
☐ Wiraswasta
☐ PNS
☐ Lainnya

Saat ini kehamilan : ☐ pertama
ke..... ☐ Ke dua
☐ Ke tiga
☐ Ke empat
☐ Ke lima

Riwayat operasi : ☐ Belum pernah
☐ Pernah

A. SOP TEKNIK RELAKSASI GENGAM JARI

Pengertian	Teknik relaksasi genggam jari adalah metode sederhana untuk menurunkan kecemasan dengan cara menggenggam dan menekan lembut setiap jari tangan secara bergantian sambil mengatur napas secara perlahan untuk menyeimbangkan emosi, menenangkan pikiran, dan menurunkan ketegangan fisik maupun psikologis.
Tujuan	1. Mengurangi tingkat kecemasan dan ketegangan. 2. Menyeimbangkan emosi dan meningkatkan relaksasi. 3. Membantu stabilisasi respons fisiologis seperti denyut nadi dan tekanan darah. 4. Meningkatkan fokus dan ketenangan diri.
Indikasi	1. Pasien yang mengalami kecemasan ringan hingga sedang (misalnya pra operasi, tindakan medis, atau stres emosional). 2. Pasien yang mampu mengikuti instruksi verbal. 3. Pasien dalam kondisi sadar dan kooperatif.
Persiapan Alat	1. Tempat duduk atau posisi berbaring yang nyaman. 2. Ruangan tenang dan minim gangguan. 3. Jam atau stopwatch untuk memantau durasi (opsional). 4. Alat pengukur tanda vital (jika diperlukan untuk memantau respons fisiologis).
Tahap Kerja	Persiapan: 1. Pastikan lingkungan tenang dan nyaman. 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah teknik kepada pasien. 3. Anjurkan pasien duduk atau berbaring dalam posisi rileks. Pelaksanaan: 1. Minta pasien menarik napas dalam melalui hidung dan menghembuskannya perlahan melalui mulut. 2. Mulai dari tangan kanan atau kiri, genggam satu jari dengan tangan lainnya. 3. Tekan lembut selama $\pm 1-2$ menit setiap jari sambil tetap mengatur napas. 4. Fokuskan perhatian pada sensasi hangat dan tenang di area genggaman. 5. Lanjutkan secara bergantian ke jari berikutnya hingga semua jari selesai. Akhir kegiatan: 1. Setelah selesai, minta pasien menarik napas panjang dan perlahan membuka genggaman. 2. Evaluasi perasaan dan kondisi pasien (fisik dan emosional). 3. Catat hasil observasi pada lembar evaluasi.

B. KUESIONER KECEMASAN

No	Gejala Kecemasan	Tidak pernah	Kadang-kadang	Cukup sering	Sering
1.	Saya merasa lebih gugup dan cemas dari biasanya				
2.	Saya merasa takut tanpa alasan sama sekali				
3.	Saya mudah marah atau merasa panik				
4.	Saya merasa seperti jatuh terpisah dan akan hancur berkeping-keping				
5.	Saya merasa bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada hal buruk akan terjadi				
6.	Lengan dan kaki saya gemetaran				
7.	saya terganggu oleh nyeri kepala, leher dan nyeri punggung				
8.	Saya merasa lemah dan mudah lelah				
9.	Saya merasa tenang dan dapat duduk diam dengan mudah				
10.	Saya merasa jantung saya berdebar-debar				
11.	Saya merasa pusing tujuh keliling				
12.	Saya telah pingsan atau merasa seperti itu				
13.	Saya dapat bernafas dengan mudah				

14.	Saya merasa jari-jari tangan dan kaki mati rasa dan kesemutan				
15.	Saya terganggu oleh nyeri lambung atau gangguan pencernaan				
16.	Saya sering buang air kecil				
17.	Tangan saya biasanya kering dan hangat				
18.	Wajah saya terasa panas dan merah merona				
19.	Saya mudah tertidur dan dapat istirahat dengan baik				
20.	Saya mimpi buruk				

Skor Total :

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama :

NIM :

Judul Proposal Skripsi:

Dosen Pembimbing 1 :

[illegible]

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama :

NIM :

Judul Proposal Skripsi:

Dosen Pembimbing 2 :

[illegible]